



• GUIA PARA PROFISSIONAIS

Guia de **Ativos** **cosméticos**

Qual ácido indicar
**para cada queixa e
fototipo**

Com **tabela de
consulta** para
imprimir.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



PARTE 1 · OS 6 ATIVOS MAIS BUSCADOS

01

O que cada ativo faz na pele

Mecanismo, para que serve e a faixa de concentração usada nos estudos e nos cosméticos. Com isso você escolhe o ativo pela queixa, e não pela moda.

Ativo	Como age	Faixa usual em cosmético
Niacinamida vitamina B3	Bloqueia a transferência de melanossomos para os queratinócitos, estimula a síntese de ceramidas (barreira) e reduz citocinas inflamatórias. Também reduz sebo.	2 a 4% (acne e sebo) 4% (manchas) 4 a 5% (envelhecimento)
Ácido tranexâmico tópico	Impede a conversão de plasminogênio em plasmina e corta mediadores que ativam o melanócito. Tem ação antiangiogênica, útil no componente vascular do melasma.	2 a 5%
Retinol vitamina A	Na pele vira retinaldeído e depois ácido retinoico. Melhora textura, linhas finas e discromia. É cerca de 20 vezes menos potente que o ácido retinoico.	0,0015 a 0,3%
Ácido salicílico beta-hidroxiácido	É lipofílico, por isso se concentra na unidade pilosebácea. Solta a coesão entre corneócitos e tem ação anti-inflamatória entre 0,5 e 5%.	Até 2% sem enxágue (limite Anvisa, Parte 3)
Ácido glicólico alfa-hidroxiácido	Molécula pequena e hidrofílica, a que mais penetra entre os AHA. Reduz a coesão da camada córnea e renova a epiderme. Quanto menor o pH, mais intenso.	Até 10%, pH $\geq$ 3,5 (peeling de 20 a 70% é procedimento)
Vitamina C ácido L-ascórbico	Antioxidante, participa da síntese de colágeno e inibe a tirosinase. Só penetra bem em pH abaixo de 3,5. O ácido ferúlico ajuda a estabilizar a fórmula.	10 a 20% (abaixo de 8% pouco efeito; acima de 20% sem ganho e mais irritação)

Derivados de vitamina C

Fosfato de ascorbil magnésio e palmitato de ascorbila são estáveis em pH neutro. Um estudo citado na revisão não mostrou aumento de ácido L-ascórbico na pele com esses derivados.

Retinoide não é tudo igual

Tretinoína e adapaleno são medicamentos. Ésteres (palmitato, acetato de retinila) precisam de duas conversões e por isso rendem menos efeito que o retinol.

Cosmético tem limite. Pela RDC 907/2024 da Anvisa, cosmético serve para limpar, perfumar, alterar a aparência, proteger ou manter a pele em bom estado. Clareador da pele, produto para pele acneica e protetor solar são Grau 2, com maior grau de vigilância sanitária.



Qual ativo para **cada** queixa

Primeiro a queixa define o ativo. Depois o fototipo define o quanto você pode irritar a pele sem gerar mancha nova.

Queixa	Ativos com evidência	O que considerar
Acne leve e comedões	Ácido salicílico, niacinamida 2 a 4%, retinol	O salicílico age dentro do folículo. Acne inflamatória, nodular ou extensa vai para o médico.
Melasma e manchas	Niacinamida 4%, ácido tranexâmico 2 a 5%, vitamina C, ácido azelaico até 10%	Sem fotoproteção diária nenhum ativo segura o resultado. Tranexâmico tópico teve redução de MASI parecida com a hidroquinona e menos irritação.
Envelhecimento e textura	Retinol, vitamina C 10 a 20%, niacinamida 4 a 5%, glicólico até 10%	Tretinoína e adapaleno são medicamentos e ficam com o médico.
Oleosidade	Niacinamida 2 a 5%, ácido salicílico	A niacinamida reduz o sebo nos estudos clínicos, mas o mecanismo ainda não é conhecido.
Pele sensível	Niacinamida (sem irritação até 5% nos testes)	Reforce a barreira antes de qualquer ácido. Ácido em pele irritada é convite para hiperpigmentação.

Fitzpatrick e risco de mancha pós-inflamatória

Tipo	Reação ao sol	Na hora de indicar ácido
I e II	Sempre queima; bronzeia pouco ou nada	Queimam fácil: com AHA, que aumenta a sensibilidade ao UV, reforce o FPS
III	Queima e bronzeia moderadamente	Melasma já é frequente (tipos III a V); avance devagar
IV a VI	Queima pouco ou quase nunca; bronzeia fácil e intenso	A hiperpigmentação pós-inflamatória é mais frequente e mais intensa. Evite empilhar irritantes



O próprio tratamento mancha

A revisão de Davis e Callender alerta: o ativo que irrita pode causar ou piorar a hiperpigmentação pós-inflamatória. Em fototipo alto, tolerância vem antes de potência.



O que a literatura documenta

Peeling de glicólico: muito seguro nos tipos I a IV. Peeling de salicílico: eficácia e segurança descritas nos tipos I a III e também V e VI.

Atenção: o consenso da SBD lembra que a escala de Fitzpatrick não é totalmente adequada para avaliar a população miscigenada brasileira. Use como ponto de partida, junto com o histórico de manchas da pessoa.



Limites, associações e quem não pode

Ativo	Regra para cosmético no Brasil	Fonte
Ácido salicílico	2% na maioria dos produtos; 3% em capilar com enxágue; 0,5% em loção corporal. Não usar em menores de 3 anos (exceto xampu).	RDC 1.029/2026, item 51
AHA (glicólico, lático)	Até 10% na forma ácida, pH $\geq$ 3,5. Entre pH 3,5 e 5,0 o produto é Grau 2.	Anvisa, Parecer Técnico nº 7/2001
Ácido azelaico	Clareador até 10%, uma vez ao dia, com advertências no rótulo.	RDC 1.029/2026, item 194
Hidroquinona	Só aparece para sistemas de unhas artificiais (0,02%, uso profissional). Não tem uso previsto como clareador cosmético.	RDC 1.029/2026, item 14
Retinol	Sem limite na lista brasileira. Na UE: 0,3% de equivalente de retinol no rosto e 0,05% em loção corporal, com o aviso "Contém vitamina A".	Reg. (UE) 2024/996
Niacinamida, tranexâmico, vitamina C	Não constam da lista de uso restrito. Vale a regularização do produto acabado.	RDC 1.029/2026

Associações que fazem sentido

Vitamina C com vitamina E e ácido ferúlico (estabiliza e reforça a fotoproteção). Niacinamida é o ativo mais bem tolerado da lista (sem irritação até 5%) e serve de base para os outros.

O que não empilhar

Glicólico, salicílico e retinol na mesma noite somam irritação, e irritação vira mancha em fototipo alto. Alterne as noites. Conduta conservadora deste guia.

Gestação

Ativo	O que as fontes dizem
Retinoides tópicos	Não incentivar o uso na gestação até haver dados de coortes maiores.
Ácido salicílico	Cosmético: absorção pequena, risco improvável. Peeling de salicílico: não recomendado.
Ácido glicólico	Cosmético tópico não deve preocupar, absorção sistêmica mínima.
Hidroquinona	35 a 45% de absorção sistêmica: minimizar a exposição.
Niacinamida, tranexâmico, vitamina C	As fontes deste guia não trazem dado. Lactação também não. Decida com o obstetra.

Fotoproteção é parte do protocolo. AHA aumenta a sensibilidade ao UV por até uma semana após parar (FDA). A SBD recomenda FPS 30 ou mais, proteção UVA de pelo menos 1/3 do FPS e reaplicação a cada 2 horas. No melasma, filtro com cor (óxido de ferro) protege também da luz visível.

Monte o home care

CÁLCULO RESOLVIDO

Caso fictício: mulher, 32 anos, fototipo IV, melasma malar leve, comedões e oleosidade, não gestante

1. Manhã: limpeza com salicílico 2% + sérum de niacinamida 4% e tranexâmico 3% + FPS 30 ou mais com cor, reaplicado a cada 2h
 2. Noite, semanas 1 a 4: niacinamida todas as noites; retinol 0,1 a 0,3% em 3 noites por semana, nunca na mesma noite de outro ácido
 3. Glicólico fica de fora no primeiro mês: fototipo IV com melasma pede tolerância antes de potência
- Checagem do kit contra a RDC 1.029/2026:
- Gel de limpeza facial (com enxágue): Ácido salicílico 2% → limite 2% → dentro do limite
- Loção corporal para foliculite: Ácido salicílico 2% → limite 0,5% → **acima**: 2% contra 0,5%
- Sérum noturno de glicólico, pH 3,8: Ácido glicólico 8% → limite 10% → dentro do limite

A loção corporal com 2% de salicílico passa do limite de 0,5% para loções corporais e não deveria estar no kit. Esquema e concentrações são ilustrativos, montados pela ITH a partir das fontes. Piora, irritação ou ausência de resposta em 12 semanas: encaminhe ao médico.

FERRAMENTA PARA PREENCHER

Tabela queixa x ativo x fototipo

Queixa	Ativo e %	Fototipo	Turno e frequência	Cuidado (sol, gestação, irritação)
Acne				
Melasma/manchas				
Envelhecimento				
Oleosidade				
Sensibilidade				

Quem indica o quê: a Lei 13.643/2018 permite ao esteticista usar cosméticos com registro na Anvisa e manda observar a prescrição médica. Enfermagem, biomedicina, fisioterapia e farmácia seguem a resolução vigente do próprio conselho; confira antes de indicar. Medicamentos ficam fora do home care cosmético.



• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. A tabela de queixas, o esquema do caso e a checagem do kit foram montados pela ITH a partir dessas fontes, sem citar marcas.

- 01 **Anvisa, RDC nº 1.029/2026: lista de substâncias de uso restrito em cosméticos (república em 25/06/2026)**
anvisa.gov.br/legis/datalegis.net (RDC 1.029/2026)
- 02 **Anvisa, Parecer Técnico nº 7/2001, atualizado em 16/02/2006: alfa-hidroxiácidos em cosméticos**
gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/cosmeticos/pareceres
- 03 **Anvisa, RDC nº 907/2024: definição e classificação de cosméticos (Grau 1 e Grau 2)**
anvisa.gov.br/legis/datalegis.net (RDC 907/2024)
- 04 **Regulamento (UE) 2024/996: vitamina A em cosméticos (resumo técnico Exponent)**
exponent.com/article/navigating-new-annex-iii-restrictions-vitamin-cosmetics
- 05 **FDA: Alpha Hydroxy Acids (CIR e estudo de fotossensibilidade)**
fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/alpha-hydroxy-acids
- 06 **Marques C et al. Niacinamide: mechanistic insights. Antioxidants, 2024**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11047333
- 07 **AlJabr A et al. Tranexamic acid for hyperpigmentation disorders. J Cosmet Dermatol, 2026**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12848551
- 08 **Zasada M, Budzisz E. Retinoids in cosmetic and dermatological treatments. Postepy Dermatol Alergol, 2019**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6791161
- 09 **Arif T. Salicylic acid as a peeling agent: a comprehensive review. Clin Cosmet Investig Dermatol, 2015**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4554394
- 10 **Sharad J. Glycolic acid peel therapy: a current review. Clin Cosmet Investig Dermatol, 2013**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3875240
- 11 **Al-Niaimi F, Chiang NYZ. Topical vitamin C and the skin. J Clin Aesthet Dermatol, 2017**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5605218
- 12 **Davis EC, Callender VD. Postinflammatory hyperpigmentation in skin of color. J Clin Aesthet Dermatol, 2010**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2921758
- 13 **Handel AC, Miot LDB, Miot HA. Melasma: a clinical and epidemiological review. An Bras Dermatol, 2014**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4155956
- 14 **Schalka S et al. Consenso Brasileiro de Fotoproteção (SBD). An Bras Dermatol, 2014**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4365470
- 15 **Fatima S et al. The role of sunscreen in melasma and PIH. Indian J Dermatol, 2020**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6986132
- 16 **Bozzo P et al. Safety of skin care products during pregnancy. Can Fam Physician, 2011**
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3114665
- 17 **Lei nº 13.643/2018 (profissões de esteticista e técnico em estética)**
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13643.htm

Ressalvas. Concentrações são faixas de estudos e de limites regulatórios, não prescrição. A lista de uso restrito da Anvisa passa por nova consulta pública (CP 1.399/2026) e pode mudar. As fontes consultadas não trazem dados de gestação para niacinamida, ácido tranexâmico tópico e vitamina C, nem de lactação para nenhum dos ativos. Avaliação individual, prescrição médica e a resolução do seu conselho prevalecem.

• PARA IR ALÉM

Quer indicar ativo com segurança e método?

Escolher o ácido certo é metade do protocolo; a outra metade é avaliar a pele, ajustar e acompanhar. A Pós em Saúde Estética Avançada da ITH reúne facial, corporal e capilar, com 5 vivências clínicas em pacientes modelo e mais de 30 técnicas.

Pós-graduação em Saúde Estética Avançada

- ✓ 5 vivências clínicas em pacientes modelo
- ✓ Mais de 30 técnicas faciais, corporais e capilares
- ✓ 600h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/estetica-captura/

Resumo em 30 segundos

2%

limite de ácido salicílico na maioria dos cosméticos no Brasil

10% · pH 3,5

teto do AHA em cosmético pela Anvisa

FPS 30+

mínimo recomendado pela SBD, reaplicado a cada 2h

IV a VI

fototipos com mais risco de mancha pós-inflamatória